

**Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Facultad de Medicina
Escuela Profesional de Enfermería**



**Nivel de conocimientos sobre el dengue y su relación con las prácticas
para su prevención en adultos que asisten a un establecimiento de
salud. La Victoria. Lima 2025**

Proyecto de Tesis

Para optar el Título Profesional de Licenciada en Enfermería

AUTOR

GONZALES VERA, Angie Tereza

ASESOR

Dra. LOLI PONCE, Rudi Amalia

Lima – Perú

2025

ÍNDICE

ÍNDICE.....	1
I. CAPÍTULO I: EL PROBLEMA.....	2
1.1. Planteamiento del problema.....	2
1.2. Objetivos.....	4
1.2.1. Objetivo general.....	4
1.2.2. Objetivos específicos.....	4
1.3. Justificación de la investigación.....	4
1.4. Limitaciones del estudio.....	5
II. CAPITULO II : BASES TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS.....	6
2.1. Marco teórico.....	6
2.1.1. Antecedentes Nacionales.....	6
2.1.2. Antecedentes internacionales.....	7
2.1.3. Referente teórico.....	9
2.2. Formulación de hipótesis.....	16
2.3. Metodología.....	16
2.3.1. Tipo, método y diseño de investigación.....	16
2.3.2. Población , muestra y muestreo.....	16
2.3.3. Variables.....	17
2.3.4. Operacionalización de variables.....	18
2.3.5. Técnica e instrumentos.....	20
2.3.6. Plan de recolección, procesamiento y análisis estadísticos de datos.....	20
2.3.7. Consideraciones éticas.....	22
III. CAPÍTULO III: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.....	23
2.4. Cronograma de trabajo.....	23
2.5. Presupuesto.....	23
2.6. Recursos disponibles.....	24
IV. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	25

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA

1.1. Planteamiento del problema

El dengue es una enfermedad vírica de importancia nacional e internacional, es causada por el virus del dengue el cual se transmite a través de la picadura del mosquito *Aedes aegypti* comúnmente encontrado en países con áreas cálidas y húmedas⁽¹⁾. El mosquito que transmite el virus se encuentra ampliamente distribuido en todo el mundo donde la incidencia de casos se ha visto en aumento durante los últimos años⁽²⁾.

En los últimos treinta años, la incidencia de la enfermedad ha aumentado en las Américas. Dentro del territorio peruano, durante el período 2024 se reportaron 273,847 casos de dengue hasta la semana epidemiológica 46, lo que significó un aumento 10.1 % más de casos en comparación con el año anterior⁽³⁾.

Frente a la preocupante situación, el Ministerio de Salud (MINSA), año tras año lleva a cabo diversas actividades para poder frenar el aumento de los casos. Una de esas actividades son las campañas de sensibilización, las cuales permiten que la población se informe sobre las medidas de prevención y control de la transmisión, evitando así la propagación del dengue mediante la adopción de prácticas saludables^(4,5).

Las actividades antes mencionadas se encuentran dentro del “Plan de prevención y control del dengue 2024”, documento técnico elaborado por el MINSA, dirigidas a cumplir con uno de los objetivos el cual es el “mejorar los conocimientos de la población sobre las causas y medidas de prevención del dengue”. De esta misma manera encontramos otro de los objetivos, enfocado en impulsar el desarrollo de investigaciones científicas para la prevención y control del dengue⁽⁶⁾.

Es así que podemos encontrar algunas investigaciones como la de Castillo⁽⁷⁾ quien pretendió determinar la relación entre los conocimientos de la enfermedad del dengue y la presentación de casos confirmados en la población peruana en el año 2020, hallando que el nivel de conocimientos era mayor en la población de aquellos departamentos que presentaron una mayor incidencia de casos de dengue; sin embargo, en aquellos departamentos con menos incidencia el nivel de conocimientos era bajo en comparación.

Con lo anteriormente mencionado, y sabiendo que en el año 2020 el departamento de Lima no era uno de los departamentos con mayor incidencia en el Perú, podemos considerar que el nivel de conocimientos de la población de ese año no era el adecuado, por lo que se ve pertinente analizar cuál es el nivel actual de conocimientos de dicha población.

En relación a los conocimientos y prácticas para la prevención del dengue, enfermería cumple un rol fundamental pues ella, junto con otros profesionales de la salud, participa en la detección precoz, manejo terapéutico y educación de la población, participación que fue evidente en gran medida en las últimas campañas de prevención y difusión de información realizada este y anteriores años.

Haciendo una precisión sobre los casos confirmados de dengue, tenemos que en el año 2024 se registraron 88 033 casos en la provincia de Lima y dentro de ella, en el distrito de La Victoria unos 493 casos⁽⁸⁾. En el periodo de prácticas de internado comunitario del mismo año, durante las campañas de sensibilización del dengue, se pudo observar que parte de la población aún no conocía bien sobre el dengue, pues si bien sabían que era una enfermedad que la transmitía un mosquito, no tenían claro qué tipo de mosquito, cómo era que se podía ver en su fase de larva o pupa, el tiempo de incubación y prácticas preventivas como el uso de repelentes, mosquiteros, identificación y eliminación de criaderos, uso de larvicida entregado por el personal de salud, entre otros.

Cuando se preguntaba a las personas sobre aquellas prácticas de prevención un porcentaje conocía algunas, otro porcentaje optaba por el silencio al no saber qué responder y otra parte manejaba información pero al momento de preguntar si las aplicaban optan por no contestar asumiendo así que no aplicaban todas las medidas. Lo mismo pude observar al ir a ciertos colegios donde, a pesar de haberse educado al personal que laboraba en la institución meses anteriores, aún se encontraban criaderos de mosquitos; viéndose así que a pesar que el personal tenía conocimientos y habían sido educados sobre cómo prevenir el dengue, las prácticas preventivas no eran aplicadas.

A pesar de las campañas informativas realizadas por el MINSA y las experiencias educativas implementadas en la comunidad, no se cuenta con

estudios actualizados en el distrito de La Victoria que permitan conocer cuál es el nivel actual de conocimientos sobre el dengue ni cómo este se relaciona con la adopción de prácticas preventivas. Este vacío de conocimiento es importante, ya que no basta con asumir que la información brindada es suficiente o que ha tenido impacto. Es necesario generar evidencia que permita identificar si existe una correspondencia entre lo que la población sabe y lo que realmente aplica, con el fin de diseñar estrategias más efectivas para el control del dengue. En este contexto, el presente estudio busca aportar evidencia actual y local sobre esta relación en adultos que acuden al centro de salud Max Arias Schreiber.

Teniendo en cuenta lo descrito en párrafos anteriores surgen las siguientes interrogantes: ¿Qué sabe la población sobre el dengue?, ¿Cuál es el nivel de conocimientos de la población sobre el dengue? ¿Qué medidas preventivas conoce la población? ¿La población está consciente del riesgo que representa el dengue para la salud? ¿Se aplican las medidas de prevención para el dengue?.

Por lo anteriormente expuesto se formula la siguiente interrogante de investigación: ¿Cuál es la relación que existe entre el nivel de conocimientos sobre el dengue y las prácticas para su prevención en adultos que asisten al Centro de Salud Max Arias Schreiber del distrito de La Victoria en el año 2025?

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo general

Determinar la relación que existe entre el nivel de conocimientos sobre el dengue y las prácticas para su prevención en adultos que asisten al centro de Salud Max Arias Schreiber del distrito de La Victoria.

1.2.2. Objetivos específicos

- Identificar el nivel de conocimientos sobre el dengue en adultos que asisten en el centro de Salud Max Arias Schreiber del distrito de La Victoria.
- Evaluar las prácticas para la prevención del dengue en adultos que asisten al centro de Salud Max Arias Schreiber del distrito de La Victoria.

1.3. Justificación de la investigación

Durante el periodo de internado comunitario, se identificó empíricamente una brecha entre los conocimientos que posee la población y las prácticas que realmente aplica para prevenir el dengue. Si bien se ha desarrollado material educativo y se han realizado campañas de sensibilización, no se tiene claridad sobre si la población está aplicando efectivamente lo aprendido. Por lo tanto, no se sabe con certeza si el nivel de conocimientos que tiene la población sobre el dengue influye o no en la adopción de prácticas preventivas.

Investigar la relación entre ambas variables permitirá comprender si el conocimiento por sí solo es un factor determinante en el cambio de conducta, o si existen otras barreras que impiden la adopción de prácticas de prevención del dengue.

Los resultados del estudio permitirán identificar los aspectos específicos que la población necesita reforzar (ya sea a nivel de información, motivación o condiciones externas) y con ello, el personal de salud, en especial el profesional de enfermería, podrá diseñar intervenciones educativas más efectivas, centradas en las necesidades reales de la comunidad.

Además, tanto los usuarios como las autoridades del Centro de Salud Max Arias Schreiber se verán beneficiados, ya que contarán con evidencia concreta para fortalecer sus estrategias de promoción y prevención, optimizando recursos y priorizando las acciones más efectivas frente al dengue.

1.4. Limitaciones del estudio

Una de las principales limitaciones del presente estudio es el uso de un muestreo no probabilístico por conveniencia, lo cual puede restringir la representatividad de los resultados y limitar su generalización a toda la población del distrito de La Victoria. Esta técnica fue seleccionada por razones prácticas, como el tiempo disponible, los recursos limitados y el acceso directo a los usuarios del centro de salud durante el periodo de recolección de datos. Aunque esta metodología permite una recolección eficiente de la información, se reconoce que los resultados reflejan las características de las personas que estuvieron disponibles y aceptaron participar, por lo que deben interpretarse con cautela en términos de su aplicabilidad a una población más amplia.

CAPITULO II : BASES TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS

2.1. Marco teórico

2.1.1. Antecedentes Nacionales

Melchorita del Rosario, en el 2023 llevó a cabo el estudio titulado “Determinación de los conocimientos y prácticas de medidas preventivas del Dengue en los pobladores que asisten al Centro de Salud Pueblo Nuevo”. Se trató de una investigación de tipo cuantitativo, descriptivo y de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 60 personas, y se utilizó la técnica de la encuesta mediante un cuestionario estructurado⁽⁹⁾.

En cuanto a los resultados, se encontró que el 63% (38) de los participantes tenía un nivel regular de conocimientos sobre las medidas preventivas del dengue, el 20% (12) presentó un nivel bueno, y el 17% (10) un nivel malo. Respecto a las prácticas, el 60% (36) mostró prácticas inadecuadas, mientras que el 40% (24) tuvo prácticas adecuadas⁽⁹⁾.

A partir de estos hallazgos, se concluyó que, si bien una parte significativa de los participantes posee conocimientos en un nivel regular, esto no se refleja en la adopción de prácticas preventivas adecuadas, lo cual evidencia una disociación entre el conocimiento y la práctica. Este resultado resalta la necesidad de reforzar las intervenciones educativas con estrategias que fomenten no solo el aprendizaje, sino también la aplicación efectiva de medidas preventivas en la vida diaria⁽⁹⁾.

Pujalla Acosta en el 2022 llevó a cabo el estudio titulado “Conocimiento y prácticas asociadas a la prevención del dengue en los pobladores del distrito de Ayna - San Francisco, Ayacucho” con el objetivo de identificar el conocimiento y prácticas preventivas del dengue en la población. La investigación fue de tipo descriptivo, observacional de corte transversal, su muestra estuvo conformada por 358 personas y utilizó la encuesta como técnica de recolección de datos⁽¹⁰⁾.

En cuanto a los resultados, se encontró que 94% de la población había recibido información sobre la enfermedad y el personal de salud fue la fuente más identificada. El 42.7% de la población no tiene acceso al servicio de agua permanentemente. El 81.4% reconoció al *Aedes aegypti* como el mosquito responsable de transmitir el dengue, de los cuales el 87.9% conocía el modo de transmisión y el 84.9% identificaron los criaderos que emplea el vector. La fiebre y el dolor de cabeza fueron los síntomas más

reconocidos. El 94.7% acostumbra almacenar agua en sus viviendas y el 31.7% lava siempre sus envases donde almacenan agua⁽¹⁰⁾.

A partir de estos hallazgos se concluyó que los habitantes están adecuadamente informados, pero el desabastecimiento de agua potable, el clima, las costumbres y otros factores predisponentes, como los socioculturales, evitan poner en práctica las medidas preventivas y de control sobre la enfermedad⁽¹⁰⁾.

Perez Roja, en el 2023 llevó a cabo el estudio titulado “Conocimientos y prácticas de prevención de la enfermedad del dengue en pobladores del AA. HH Bellavista Nanay, Iquitos” con el objetivo de determinar el nivel de conocimientos y prácticas de prevención de la enfermedad. La investigación fue de tipo cuantitativa, con un diseño no experimental, descriptivo, correlacional, transversal y prospectivo, su muestra estuvo conformada por 222 habitantes de la zona y utilizó la técnica de la encuesta y la observación⁽¹¹⁾.

En cuanto a los resultados, se encontró que el 64,4% de los pobladores calificaron con nivel de conocimiento medio sobre prevención de la enfermedad, el 30,6% con un nivel bajo y el 5,0% con un nivel alto. Respecto a las prácticas de prevención los resultados mostraron predominancia de las prácticas inadecuadas en un 87,8%, mientras que el 12,2% de ellos realizan prácticas adecuadas⁽¹¹⁾.

A partir de estos hallazgos se concluyó que a pesar de ser una zona endémica para el Dengue persiste una gran cantidad de pobladores que desconocen las medidas preventivas hacia esta enfermedad. Y pese a la gran campaña de prevención que se realiza aún los pobladores no se concientizan de llevar buenas prácticas en forma permanente⁽¹¹⁾.

2.1.2. Antecedentes internacionales

Mateus D. y colaboradores, en el 2023 realizaron una investigación titulada “Dengue en Barbosa (Santander, Colombia): conocimientos, actitudes y prácticas en la comunidad”, cuyo objetivo fue evaluar la comprensión y el comportamiento de la población del municipio de Barbosa acerca del virus del dengue y su vector. El estudio fue de tipo descriptivo transversal con fase analítica. La muestra estuvo conformada por 93 habitantes, y la técnica de recolección de datos utilizada fue la encuesta⁽¹²⁾.

Los resultados evidenciaron que el 78,5 % de los encuestados presentaban conocimientos deficientes sobre el dengue; sin embargo, el 67,7 % manifestó tener buenas prácticas preventivas⁽¹²⁾.

A partir de los hallazgos se concluyó que existe una disociación entre el nivel de conocimiento y la aplicación de medidas preventivas, lo que resalta la necesidad de intervenciones que fortalezcan ambos aspectos⁽¹²⁾.

Sánchez M. y colaboradores, en el 2024, realizaron un estudio titulado “Conocimientos, actitudes y prácticas sobre el dengue, en población escolar de un municipio al norte de Colombia” con el objetivo de identificar los conocimientos, actitudes y prácticas sobre el dengue en escolares de dos instituciones de educación pública. El estudio fue de tipo descriptivo, transversal con una muestra de 581 estudiantes y el uso de la encuesta como técnica de recolección de datos⁽¹³⁾

Los resultados mostraron que el 94,5 % de los participantes había oído hablar del dengue, pero solo el 63,2 % identificó correctamente que es causado por un virus. Asimismo, el 94 % sabía que es transmitido por mosquitos infectados. Sin embargo, el 57,7 % no se consideraba en riesgo de contraer la enfermedad, el 42,2 % atribuía la erradicación de criaderos únicamente a las autoridades de salud, y el 56,6 % reconocía su responsabilidad en la transmisión del dengue en su entorno⁽¹³⁾.

En cuanto a las prácticas, se observaron buenos hábitos en la limpieza del hogar y la eliminación de criaderos, aunque se evidenció una baja utilización, toldillos y ropa protectora para prevenir las picaduras⁽¹³⁾.

Se concluyó entonces, que los estudiantes presentaron buenos conocimientos sobre el dengue; sin embargo, era necesario fortalecer las actitudes y algunas prácticas para su prevención y control⁽¹³⁾.

Elsinga J. y colaboradores realizaron un estudio titulado "Conocimientos, actitudes y prácticas preventivas frente al dengue en Maracay, Venezuela" con el objetivo de identificar los factores que influyen en las prácticas comunitarias de prevención del dengue en un área urbana de alta transmisión en Venezuela. El estudio fue de tipo descriptivo, transversal; con una muestra de 105 hogares en los cuales se entrevistó a una sola persona de cada hogar para la recolección de datos⁽¹⁴⁾.

Los resultados evidenciaron que el 80 % de los hogares utilizaba entre una y cinco prácticas preventivas (como el uso de repelentes o insecticidas); sin embargo, en el 57 % de las viviendas se identificaron posibles criaderos de

Aedes spp., tanto en interiores como exteriores, muchos de ellos positivos para larvas o pupas. Las prácticas preventivas se asociaron significativamente con una infección previa por dengue y con un mayor conocimiento sobre los síntomas y la vía de transmisión del virus. A su vez, el conocimiento se vinculó con el hecho de sentirse en riesgo, haber tenido infección previa, y la exposición a fuentes informativas sobre el dengue⁽¹⁴⁾.

Se concluyó entonces que aunque el nivel de conocimiento de la comunidad sobre las vías de transmisión era alto, y la mayoría de las personas tomaron medidas para evitar las picaduras de mosquitos, los posibles sitios de reproducción de mosquitos estaban presentes en casi dos tercios de las propiedades examinadas⁽¹⁴⁾.

2.1.3. Referente teórico

2.1.3.1. Conocimientos sobre el dengue

Los conocimientos sobre el dengue implican la información que la población maneja acerca de la enfermedad: cómo se transmite, sus signos, síntomas y las medidas de prevención.

La adquisición de conocimientos adecuados permite a la población ser consciente del impacto que tiene la enfermedad en la persona y la comunidad, además de aumentar la disposición de las personas a adoptar medidas de prevención.

El dengue es una enfermedad que ha requerido el despliegue de diversas medidas para contener su propagación, las cuales están plasmadas en el Plan de Prevención y Control del Dengue, un decreto supremo emitido por el Gobierno Peruano. Dentro de este plan se encuentran intervenciones específicas, como las campañas de concientización⁽⁶⁾.

Estudios han demostrado que una población con altos niveles de conocimiento sobre el dengue es más propensa a implementar medidas preventivas. Sin embargo, en contraposición, otros estudios muestran que no siempre un alto nivel de conocimientos implica una buena adopción de prácticas preventivas. Es importante señalar que el conocimiento, aunque esencial, no siempre se traduce automáticamente en la adopción de prácticas saludables. Factores como el acceso a recursos, las creencias culturales y las percepciones de riesgo también pueden influir en la implementación de medidas preventivas, lo que resalta la necesidad de investigar esta relación en profundidad.

2.1.3.2. Adopción de prácticas para prevención del dengue

La adopción de prácticas para la prevención del dengue implica que la población reciba y haga propia la información sobre cómo prevenir la

enfermedad, aplicando así las acciones correctas de eliminación de criaderos y protección personal contra las picaduras de mosquitos⁽⁶⁾.

Prácticas para la eliminación de criaderos:

- Tapar los recipientes que contengan agua (tanques, barriles, entre otros).
- Lavar y escobillar los interiores y bordes de los depósitos donde se almacene agua.
- Evitar que se acumule agua en el escurridor de platos, bandejas del refrigerador, sumideros de macetas, y otros.
- Mantener boca abajo objetos útiles en desuso como baldes, frascos, tachos, entre otros.
- Mantener limpios y tapados los tanques elevados de agua.
- Reemplazar el agua por arena húmeda en los floreros dentro de las viviendas, iglesias o cementerios; o, de ser factible, emplear flores artificiales.
- Cambiar el agua de las flores acuáticas y escobillar los bordes de los envases cada 3 días.
- Eliminar todos los objetos en desuso (inservibles) que puedan acumular agua de lluvia, como latas, botellas vacías, cáscaras de coco, llantas, depósitos descartables, entre otros, en el patio, huerta o alrededor de la vivienda.
- Eliminar objetos en desuso de las instituciones públicas y privadas, mercados, cementerios y otros espacios públicos.

Prácticas de protección personal

- Evitar la automedicación con medicamentos contraindicados para el dengue, como los antibióticos, corticoides y antiinflamatorios no esteroideos.
- Vestir ropa que cubra la piel expuesta (pantalón, mangas largas, entre otras prendas).
- Utilizar repelentes de zancudos sobre la piel expuesta y en la ropa. Se recomienda emplear repelentes que contengan DEET, ya que son seguros durante el periodo gestacional, de lactancia y en niños mayores de 2 meses de edad. La aplicación debe realizarse cada 4 horas, con una concentración de DEET superior al 15-20%.

La adopción de prácticas saludables contribuye, en gran medida, a la disminución de casos de dengue en las comunidades. Sin embargo, la efectivización de dichas prácticas no siempre llega a concretarse, ya que diversos factores intervienen en el cambio de comportamiento de las personas. Estos factores son explicados por el Modelo de Creencias en Salud y el Modelo de Promoción de la Salud de Nola Pender, los cuales serán detallados en puntos posteriores.

2.1.3.3. Conceptos básicos del dengue

Dengue: Enfermedad infecciosa aguda de etiología viral, transmitida por la picadura del mosquito hembra infectada con el virus, principalmente del género *Aedes aegypti*, el mosquito predomina en zonas tropicales y subtropicales⁽¹⁵⁾.

Dengue sin signos de alarma

- Cefalea
- Mialgia
- Artralgia
- Dolor ocular o retro ocular
- Náuseas/ Vómitos
- Rash / Exantema

Dengue con signos de alarma

- Dolor abdominal intenso y continuo o dolor a la palpación del abdomen.
- Vómitos persistentes.
- Sangrado de mucosas y/o piel de cualquier tipo: Gingivorragia, epistaxis, metrorragia, hipermenorrea y hematomas.
- Letargo, inquietud o irritabilidad.
- Derrame seroso al examen clínico o por estudio de imágenes (ascitis, derrame pleural o derrame pericárdico)
- Lipotimia
- Hepatomegalia (mayor a 2 cm por debajo del reborde costal derecho).
- Aumento progresivo del hematocrito.

Transmisión del dengue: El dengue se transmite por la picadura de un mosquito hembra infectado a un huésped susceptible, estos mosquitos pueden picar a cualquier hora del día pero por las mañanas y últimas horas de la tarde son donde se acentúan más⁽¹⁵⁾.

Criadero de zancudos: Lugar favorable para la reproducción de zancudos. Estos pueden ser cualquier objeto donde se acumula agua⁽¹⁵⁾.

Vigilancia comunitaria: Modalidad organizada y conducida por el Establecimiento de Salud del Primer Nivel de Atención en su jurisdicción el cual promueve la participación de las comunidad, trabajando con agentes comunitarios que son debidamente capacitados para apoyar la promoción de la salud, detectar e identificar a aquellos vecinos con riesgos o problemas de salud; así como riesgos medio ambientales y sociales que puedan generar problemas en la salud de la población, ante lo cual informan al establecimiento de salud de la jurisdicción y a la autoridad competente⁽¹⁵⁾.

2.1.3.4. Teorías

Para fundamentar el estudio de la relación entre conocimientos y adopción de prácticas saludables se ampliará dos teorías: El Modelo de Creencias en Salud (MCS) y el Modelo de Promoción de la salud de Nola Pender; estas dos teorías son complementarias.

Modelo de Creencias en Salud

Las bases para El Modelo de Creencias en Salud (MCS) surgió aproximadamente en la década de los 50 con un grupo de psicólogos entre los cuales se encontraban G.M. Hochbaum, S.S. Kegeles, H. Leventhal e I.M. Rosenstock, quienes pertenecían a la organización Public Health Service. El MCS nace como una manera de entender por qué las personas se negaban a tomar conductas preventivas hacia diversas enfermedades; implicaba una visión psicológica, social y pragmática que hasta la fecha es aplicada para entender las creencias en salud de la población. El modelo consta de componentes y dimensiones que serán descritos a continuación^(16,17).

Componentes

Los componentes básicos del modelo derivan de la hipótesis de que la conducta de las personas descansa principalmente en dos variables: a) el valor que el sujeto atribuye a una determinada meta y b) la estimación que ese sujeto hace de la probabilidad de que una acción dada llegue a conseguir esa meta. Traduciendo las variables al campo de la salud tenemos lo siguiente:

- a) El deseo de evitar la enfermedad
- b) La creencia de que una conducta saludable específica puede prevenir la enfermedad

Dimensiones:

- a) Susceptibilidad percibida: Refiere la percepción que cada individuo tiene sobre el riesgo de contraer alguna enfermedad. Va desde aquella persona que niega totalmente la posibilidad de contraerla, pasando por aquella que considera probable por “estadística” contraerla sin creer verdaderamente en el riesgo hasta la persona que se considera verdaderamente en peligro de contraer la enfermedad.
- b) Severidad percibida: Hace alusión a la gravedad que implica contraer una determinada enfermedad, trayendo consigo consecuencias de tipo medico clinicas (muerte, incapacidad o dolor)

y sociales (detrimento de las relaciones sociales, efectos sobre la capacidad laboral o sobre las relaciones familiares, entre otros).

- c) Beneficios percibidos: Implica la creencia de que determinadas acciones verdaderamente ayudarán a la prevención de contraer la enfermedad. Por lo que, a pesar de que una persona crea estar en verdadero riesgo de contraer una enfermedad y muestre preocupación por los efectos implicados, no optará por realizar actividades preventivas si no cree que estas son efectivas.
- d) Barreras percibidas: Hace referencia a los aspectos potencialmente negativos que implica tomar determinadas acciones para la prevención de una enfermedad. Por ejemplo, un individuo puede creer en la eficacia de ciertas acciones para la prevención de la enfermedad pero a su vez la puede ver costosas o desagradables, viéndose comprometida la realización de esas acciones.

En relación al presente estudio, este modelo permite explicar que el conocimiento sobre el dengue y sus formas de transmisión influye directamente sobre la percepción del riesgo. Si una persona no se considera susceptible al dengue o no lo percibe como una amenaza seria, es probable que no adopte medidas preventivas, aun si conoce cuáles son. Asimismo, si percibe que dichas medidas son costosas, ineficaces o difíciles de realizar, también puede evitarlas. Por tanto, el MCS ayuda a entender cómo el conocimiento debe ir acompañado de percepciones positivas y realistas para que se traduzca en prácticas efectivas.

Modelo de promoción de la salud de Nola Pender

El modelo de promoción de la salud (MPS) de Nola Pender surgió para poder comprender las decisiones que las personas toman respecto al cuidado de su salud. Pender creía que la conducta de los individuos está motivada por los deseos de alcanzar su bienestar y potencial. El modelo integra la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura y el modelo de valoración de expectativas de la motivación humana de Feather. El MPS consta de once componentes los cuales se pueden agrupar de la siguiente forma^(18,19):

A. Características y experiencia individuales

- Conducta previa relacionada: Aquellas experiencias que la persona tuvo y que pudieran tener efectos directos e indirectos en la probabilidad de comprometerse con las conductas de promoción de la salud.
- Factores personales: Son las características biológicas, psicológicas y socioculturales, que según literatura de cierta

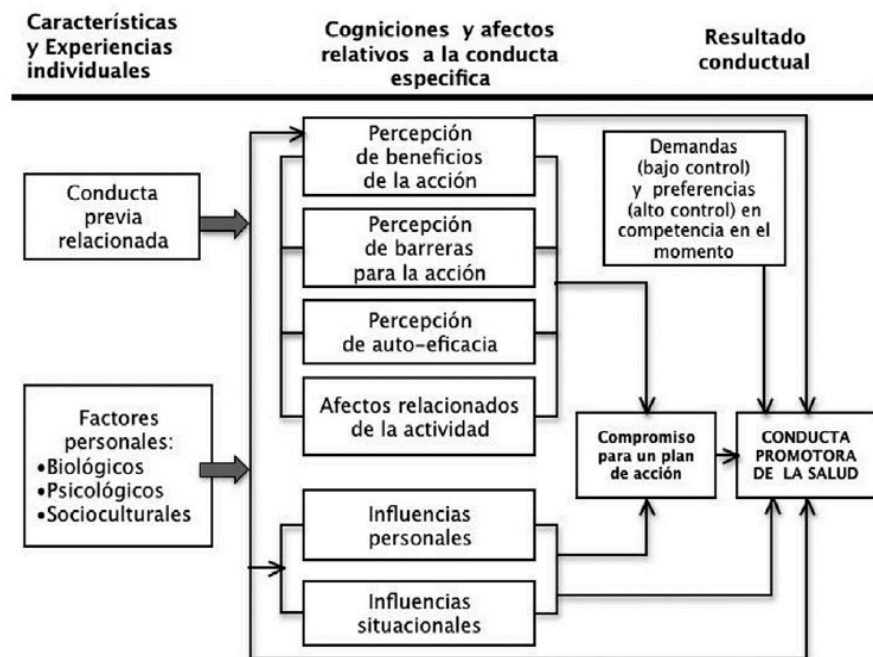
manera brinda una predicción de las conductas de las personas.

B. Cogniciones y afectos relativos a la conducta específica:

- Beneficios percibidos: Aquellos resultados positivos que se puede obtener de llevar a cabo una determinada acción.
- Barreras percibidas: Al igual que el MCS hace referencia a los aspectos potencialmente negativos que implica tomar determinadas acciones para la prevención de una enfermedad.
- Autoeficacia percibida: Hace referencia a la percepción que uno tiene de sí mismo de ser capaz de llevar a cabo cierta acción, en este caso prácticas de prevención de la salud. Además, una autoeficacia conlleva a la disminución de barreras percibidas.
- Afecto relacionado con el comportamiento: Son las emociones que la persona experimenta al realizar ciertas conductas de prevención, éstas pueden ser tanto favorables como desfavorables.
- Influencias personales: Se considera a todo aquello que aliente a la persona a realizar la conducta esperada por lo que se considera que es más probable que una persona opte por adoptar una conducta de prevención de su salud si las personas importantes para ella esperan ello.
- Influencias situacionales: Aquellas circunstancias o entornos que facilitan o dificultan la adopción de prácticas preventivas.

C. Resultado conductual

- Compromiso para un plan de acción: Precedente de la conducta promotora
- Conducta promotora: Suma de la intención y acción de adoptar comportamientos saludables.



Fuente: Modelo de promoción de la Salud de Pender 1996. En: Cid PH, Merino JE, Stieповich JB²¹

En el contexto del presente estudio, este modelo permite comprender cómo el conocimiento sobre el dengue, junto con experiencias previas, el entorno social y las emociones asociadas, puede influir en la decisión de adoptar prácticas preventivas como el uso de mosquiteros, ropa adecuada o la eliminación de criaderos.

En conjunto, ambos modelos explican que los conocimientos sobre el dengue no basta por sí solo para garantizar la prevención; es necesario que este conocimiento se integre con percepciones de riesgo, creencias en la eficacia de las acciones, habilidades personales, apoyo social y entornos favorables, lo cual facilita o limita la práctica efectiva de medidas preventivas.

Sin embargo, dentro de esta red de factores interrelacionados, el conocimiento sigue desempeñando un papel clave. Si bien los conocimientos no son el único factor que determina la adopción de prácticas para la prevención del dengue, sí constituyen un pilar fundamental dentro del proceso de toma de decisiones en salud. El conocimiento actúa como base sobre la cual se desarrollan otras percepciones clave, como la susceptibilidad y severidad percibidas, los beneficios esperados y la identificación de barreras^(17,19). Es decir, una persona no puede valorar adecuadamente su riesgo ante el dengue, ni reconocer la efectividad de las acciones preventivas, si no ha recibido información clara y suficiente sobre la enfermedad y sus mecanismos de prevención. Por ello, aunque el conocimiento por sí solo no garantiza la conducta preventiva, está presente de forma transversal en los procesos cognitivos y afectivos que promueven el cambio de comportamiento.

2.2. Formulación de hipótesis

Hipótesis nula (H_0) : No existe relación significativa entre el nivel de conocimientos sobre el dengue y las prácticas para su prevención en adultos que asisten a un establecimiento de salud, La Victoria – Lima, 2025.

Hipótesis alterna (H_1) : Existe relación significativa entre el nivel de conocimientos sobre el dengue (alto, medio, bajo) y las prácticas para su prevención en adultos que asisten a un establecimiento de salud, La Victoria – Lima, 2025.

2.3. Metodología

2.3.1. Tipo, método y diseño de investigación

El presente estudio se clasifica como de tipo correlacional, ya que tiene como objetivo principal determinar la relación existente entre las variables de conocimientos y prácticas para la prevención del dengue. El enfoque metodológico es cuantitativo, dado que se emplearán cuestionarios estructurados para medir ambas variables a través de datos numéricos, lo que permite un análisis objetivo y sistemático. Por último, el diseño de la investigación es no experimental, debido a que no se realizará manipulación de las variables, y de corte transversal, al recolectar los datos de la población en un único momento en el tiempo.

2.3.2. Población , muestra y muestreo

Población : La población del presente estudio estará constituida por personas que se encuentren en la etapa de vida adulta joven (18 años a 29 años 11 meses y 29 días) y en la etapa de vida adulta (30 años a 59 años 11 meses y 29 días)⁽²⁰⁾ que acuden al Centro de Salud Max Arias Schreiber, ubicado en el distrito de La Victoria, y que cumplan con los criterios de inclusión establecidos.

Criterios de inclusión :

- Personas usuarias del centro de salud en la etapa de vida adulta joven y adulta.
- Residentes del distrito de La Victoria.
- Personas que otorguen su consentimiento informado para participar en el estudio.

Criterios de exclusión :

- Personas con alteración cognitiva significativa o condiciones que impidan la comprensión/participación.

- Personal del Centro de Salud (empleados, contratistas, practicantes) y personal de la investigación.
- Personas que hayan participado previamente en la prueba piloto o en un pretest del mismo instrumento

Muestra: El tamaño de la muestra fue calculado considerando la población en etapa de vida adulta joven y adulta que acuden al Centro de Salud Max Arias Schreiber, estimada en 1130 personas por mes, según datos de la oficina de estadística del centro de salud del año 2023. Para determinar el tamaño muestral, se utilizó la fórmula para poblaciones finitas, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. Esto dio como resultado un tamaño muestral de 288 personas.

Muestreo: Se empleará un muestreo no probabilístico por conveniencia, el cual consiste en seleccionar a los participantes que estén disponibles y cumplan con los criterios de inclusión, durante el periodo de recolección de datos. La elección de esta técnica responde a la accesibilidad y facilidad para contactar a los sujetos de estudio, ya que se realizará la encuesta de manera presencial a las personas que acudan al Centro de Salud Max Arias Schreiber, y que acepten participar voluntariamente. Esta estrategia permite una recolección eficiente de la información dentro del tiempo y los recursos disponibles para el presente estudio.

2.3.3. Variables

Variable 1: Nivel de conocimientos sobre el dengue.

Variable 2 : Prácticas para la prevención del dengue.

2.3.4. Operacionalización de variables

Variable	Definición conceptual	Dimensión	Indicadores	Valor final	Definición operacional
Nivel de conocimientos sobre el dengue	Calidad y cantidad de información que una persona posee acerca del dengue, incluyendo cómo se transmite, sus signos, síntomas y las medidas de prevención.	Transmisión del dengue	Conocimiento sobre el vector del dengue.	Alto (6 - 9) Medio (3 - 5) Bajo (0 - 2)	Calidad y cantidad de información que poseen las personas en etapa de vida adulta joven (18 años a 29 años 11 meses y 29 días) y adulta (30 años a 59 años 11 meses y 29 días) que asisten al Centro de Salud Max Arias Schreiber sobre cómo se transmite el dengue, síntomas y medidas de prevención. Se evaluará mediante un cuestionario estructurado. Los resultados serán clasificados como alto, medio o bajo.
			Conocimiento sobre el modo de transmisión.		
		Signos y síntomas	Conocimiento sobre los síntomas y signos iniciales.		
			Conocimientos sobre los signos de alarma.		
		Prevención	Conocimiento de medidas para eliminar criaderos.		
			Conocimiento sobre protección personal.		
Prácticas para la prevención del dengue	Acciones destinadas a prevenir el dengue, basadas en la información recibida sobre la enfermedad. Estas acciones	Eliminación de criaderos	Mantiene los objetos de almacenamiento de agua tapados y limpios.	Adecuada (5 - 6)	Acciones para prevenir el dengue realizadas de manera activa por parte de las personas en etapa de vida adulta joven y adulta que
			Elimina los objetos en desuso	Parcialmente adecuada (3 - 4) Inadecuada (0 - 2)	

	incluyen la eliminación de criaderos de mosquitos y el uso de repelentes.		que puedan acumular agua.		asisten al Centro de Salud Max Arias Schreiber en sus hogares u otros entornos, basadas en la información recibida sobre la enfermedad y experiencias previas. Estas acciones incluyen la eliminación de criaderos de mosquitos y el uso de repelentes. Se evaluará mediante un cuestionario estructurado. Los resultados serán clasificados como adecuado, parcialmente adecuado o inadecuado.
			Evita tener floreros con agua o los reemplaza con arena.		
		Protección personal	Uso de ropa adecuada.		
			Uso de repelente.		
			Uso de mosquitero.		

2.3.5. Técnica e instrumentos

La técnica empleada para la recolección de datos será la encuesta, la cual permitirá obtener información estandarizada y comparable sobre el nivel de conocimientos sobre el dengue y las prácticas para su prevención, además de recoger datos generales de los participantes como edad, sexo y nivel educativo, lo cual facilitará un análisis más integral.

Se utilizarán dos cuestionarios estructurados, uno por cada variable. Ambos instrumentos son de autoría propia tomando como referencia los lineamientos del “Plan de Prevención y Control del Dengue 2024” del Ministerio de Salud (MINSA) y adaptando ítems de instrumentos utilizados en estudios previos, como los de Pujalla Acosta (2023) y Mateus et al. (2023), asegurando así su adecuación al contexto peruano y a los objetivos del presente estudio.

Para garantizar su validez, los cuestionarios fueron sometidos a un proceso de validación por juicio de expertos. Se invitó a tres profesionales con experiencia en salud pública, epidemiología y/o metodología de la investigación, quienes evaluaron cada ítem en cuanto a su claridad, coherencia y relevancia respecto a los objetivos del estudio.

Los juicios fueron analizados aplicando el Coeficiente de Validez de Contenido propuesto por Hernández-Nieto, el cual permitió cuantificar la validez del contenido

Finalmente, luego del análisis de los juicios y del cálculo del coeficiente, se realizaron los ajustes necesarios para perfeccionar los cuestionarios y proceder a su aplicación.

Además de ello, para garantizar la calidad de los instrumentos, se realizó también una prueba piloto con 30 personas con características similares a la población de estudio.

En el caso del cuestionario de conocimientos sobre el dengue, inicialmente contó con 8 ítems. Tras la revisión de los resultados de la prueba piloto, se realizó la modificación de algunas preguntas y se añadió un ítem, quedando conformado por 9 preguntas. Debido a que los ítems son dicotómicos, se aplicó el coeficiente Kuder-Richardson 20 (KR-20), obteniéndose un valor de 0.716, lo que indica una confiabilidad aceptable.

Respecto al cuestionario de prácticas preventivas, comenzó con 7 ítems y, luego de la revisión, se realizaron ajustes y se redujo a 6 preguntas.

Al tratarse también de respuestas dicotómicas, se aplicó el coeficiente KR-20, obteniéndose un valor de 0.719, considerado aceptable para su aplicación en el estudio.

2.3.6. Plan de recolección, procesamiento y análisis estadísticos de datos

1. **Recolección de datos** : Para iniciar la recolección de datos, se validará previamente el instrumento a través del juicio de expertos y se calculará el coeficiente de validez de contenido. Luego, se gestionará la aprobación del proyecto por parte de la Escuela de Enfermería, verificando que cumpla con los criterios metodológicos y éticos establecidos. Posteriormente, se solicitará la autorización a la Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRIS) Lima Centro, presentando la documentación requerida para obtener el permiso formal que habilite la aplicación del instrumento en el Centro de Salud Max Arias Schreiber.

Una vez obtenidas todas las autorizaciones, se procederá con la aplicación del cuestionario durante el mes de junio de 2025. La recolección de datos se realizará de manera presencial en las áreas de espera del centro de salud, específicamente en los ambientes de consultorios de medicina, inmunizaciones, CRED, ITS y ESPCT. Durante estas visitas, se abordará a los usuarios mayores de edad que se encuentren en dichas áreas, verificando previamente que cumplan con los criterios de inclusión.

La investigadora se presentará de manera cordial ante los usuarios, explicará los objetivos y propósito del estudio, y solicitará su participación voluntaria. A quienes acepten, se les entregará el consentimiento informado para su lectura y firma. Luego, se proporcionará el cuestionario impreso, el cual será autoaplicado. Una vez completado, el cuestionario será recogido por la investigadora y almacenado cuidadosamente en una carpeta física para su posterior análisis.

ACTIVIDAD	FECHA	DETALLES
Validación del instrumento	4 - 14 de abril	Juicio de expertos y cálculo del coeficiente de validez
Aprobación institucional del proyecto	21 de abril - 30 de junio	Revisión por comité de ética e investigación
Solicitud de autorización a DIRIS Lima Centro	01 julio - 20 de setiembre	Presentación formal del proyecto
Recolección de datos en	20 de septiembre - 20	Aplicación del

campo	de octubre	cuestionario en el C.S. Max Arias Schreiber
-------	------------	--

2. **Procesamiento:** Cada cuestionario recolectado será identificado con un código único para asegurar la organización y trazabilidad de la información. Posteriormente, los datos registrados en los cuestionarios físicos serán transcritos manualmente a una hoja de cálculo en Microsoft Excel, realizando tablas para cada variable y verificando que no existan errores de digitación mediante una doble revisión. Esta hoja de cálculo conformará la matriz de datos, donde cada fila representará a un participante y cada columna un ítem los cuales estarán ordenados para poder analizarlos por dimensión y de manera global. Una vez completada y validada la matriz, se procederá a su exportación al software estadístico SPSS para su análisis estadístico.
3. **Análisis estadístico:** El análisis de los datos se desarrollará en dos fases.

Análisis descriptivo:

Se utilizarán frecuencias absolutas y relativas (porcentajes) para describir las características sociodemográficas de la muestra, así como los niveles de conocimiento y las categorías de prácticas preventivas frente al dengue. Los resultados se presentarán en tablas y gráficos para facilitar su interpretación.

Análisis inferencial:

Para evaluar la relación entre el nivel de conocimientos sobre el dengue y las prácticas para su prevención, se aplicará la prueba estadística Chi-cuadrado (X^2), la cual permitirá determinar si existe asociación significativa entre ambas variables. El nivel de significancia considerado será $p < 0.05$.

2.3.7. Consideraciones éticas

La presente investigación se enmarca dentro del respeto estricto a los principios bioéticos fundamentales: autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia.

Se garantizará la autonomía de los participantes mediante la obtención del consentimiento informado de forma voluntaria, previa explicación clara y comprensible sobre los objetivos, fines, procedimientos, beneficios y posibles riesgos del estudio. En ningún momento se ejercerá presión o coacción para su participación.

Se asegurará la beneficencia, ya que el estudio busca generar conocimientos que permitan mejorar las estrategias educativas y de prevención del dengue, beneficiando directamente a la comunidad involucrada y al sistema de salud.

El principio de no maleficencia se respetará evitando cualquier daño físico, psicológico o social a los participantes. La recolección de datos no implicará procedimientos invasivos ni riesgos para la salud, y se mantendrá en todo momento un trato digno y respetuoso.

Se cumplirá con el principio de justicia, garantizando que la participación esté abierta a toda persona que cumpla con los criterios de inclusión, sin discriminación de ningún tipo, y que los beneficios del estudio puedan extenderse a toda la población atendida por el establecimiento de salud.

La confidencialidad de la información será resguardada mediante la codificación de los cuestionarios y el uso exclusivo de los datos para fines académicos. Estos serán almacenados en dispositivos protegidos con clave de acceso y no se divulgarán datos personales que permitan la identificación de los participantes.

Finalmente, el proyecto será sometido a evaluación y aprobación por el Comité de Ética de la Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, garantizando el cumplimiento de los estándares éticos y normativas vigentes en investigación con seres humanos.

CAPÍTULO III: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

2.4. Cronograma de trabajo

Actividad	Responsable	Inicio	Fin
Revisión bibliográfica	Investigadora	27/01/2025	28/01/2025
Elaboración de matriz de consistencia	Investigadora	29/01/2025	30/01/2025
Elaboración de instrumento	Investigadora	31/01/2025	02/02/2025
Validación del instrumento	Investigadora	24/03/2025	14/04/2025
Gestión de aprobación de proyecto por escuela	Investigadora	21/04/2025	30/06/2025
Gestión de aprobación de proyecto por Diris Lima Centro	Investigadora	01/08/2025	20/09/2025
Aplicación de instrumento	Investigadora	20/09/2025	20/10/2025
Procesamiento y análisis de datos	Estadístico	20/10/2025	27/10/2025
Redacción de resultados	Investigadora	27/10/2025	31/10/2025
Elaboración de informe final	Investigadora	01/11/2025	30/11/2025
Revisión y correcciones	Investigadora	01/12/2025	15/12/2025
Sustentación	Investigadora	-	-

2.5. Presupuesto

Categoría	Detalle	Costo unitario (s/.)	Cantidad	Total
Bienes	Libros	100	3	300
	Paquete de hojas A4	15	4	60
	Materiales de escritorio	2	100	200
Servicios	Movilidad	10	30	300
	Alimentos	10	20	200
	Impresiones	10	18	180
	Servicio estadístico	300	1	300

Categoría	Detalle	Costo unitario (s/.)	Cantidad	Total
				1540

2.6. Recursos disponibles

Para llevar a cabo la investigación, se utilizarán los siguientes recursos:

- Recursos Humanos
 - Investigador principal: Responsable de la planificación, ejecución, análisis de datos y redacción del informe final.
- Recursos Materiales
 - Papelería y materiales de escritorio.
 - Cuestionarios impresos: Para la aplicación de encuestas a los participantes.
 - Equipo de cómputo: Para el almacenamiento y análisis de los datos recopilados.
- Recursos Institucionales
 - Sede de DIRIS Lima Centro: Apoyo institucional para la coordinación y permisos relacionados con la investigación.
 - Escuela Profesional de Enfermería - UNMSM: Proporciona asesoramiento académico, validación del proyecto, y revisión ética por parte del Comité de Ética.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Dengue [Internet]. Paho.org. [cited 2025 Apr 17]. Available from: <https://www.paho.org/es/temas/dengue>
2. Dengue and severe dengue [Internet]. Who.int. [cited 2025 Apr 17]. Available from: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dengue-and-severe-dengue>
3. CDC Perú emite alerta epidemiológica por incremento de casos de dengue en el Perú [Internet]. CDC MINSA. 2024 [cited 2025 Apr 17]. Available from: <https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/informativo/prensa/cdc-peru-emite-alerta-epidemiologica-por-incremento-de-casos-de-dengue-en-el-peru/>
4. Telecapacitaciones [@telesaludminsatelecapa]. (2024, febrero 27). DENGUE. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=FNEkfsm88G8>
5. Telesalud Hospital Nacional Cayetano Heredia [@telesaludhospitalcayetanoh5846]. (2025, enero 16). Dengue: Situación actual y manejo clínico. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=H7u9MJpdh1o>
6. Ministerio de Salud. Plan de prevención y control del dengue 2024 [Internet]. Gob.pe. 2024 [citado el 28 de enero de 2025]. Disponible en: <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/5813240/5156456-resolucion-ministerial-n-082-2024.pdf>
7. Muñoz C. Conocimientos preventivos acerca del dengue y su relación con la presentación de casos en la población peruana el año 2020 [Internet]. Repositorio de la UPCH. 2020 [citado el 28 de enero de 2025]. Disponible en: https://repositorio.upch.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12866/12443/Conocimientos_CastilloMunoz_Maite.pdf?sequence=1&isAllowed=y
8. Minsa. MAPA DE CALOR DE DENGUE [Internet]. CDC Ministerio de Salud del Perú. [citado el 28 de enero de 2025]. Disponible en: <https://app7.dge.gob.pe/maps/denguemap/>
9. Melchorita A. Conocimientos y prácticas de medidas preventivas del dengue en los pobladores que asisten al Centro de Salud Pueblo Nuevo 2023 [Internet]. Repositorio de la UPSJB. 2024 [citado el 28 de enero de 2025]. Disponible en: <https://repositorio.upsjb.edu.pe/item/4428e3c7-7cb6-4193-8b37-2467fe56534a>
10. Pujalla J. Conocimiento y prácticas asociadas a la prevención del dengue en los pobladores del distrito de Ayna - San Francisco [Internet]. Universidad Peruana Cayetano Heredia; 2022 [citado el 28 de enero de 2025]. Disponible en: <https://hdl.handle.net/20.500.12866/12952>
11. Paredes Rojas D. Conocimientos y prácticas de prevención de la enfermedad del dengue en pobladores del AA. HH Bellavista Nanay, Iquitos 2023 [Internet]. Alicia. 2023 [citado el 28 de enero de 2025]. Disponible en: <http://hdl.handle.net/20.500.14503/2808>
12. Mateus Escobar DA, Monroy Díaz AL, Jaimes-Bernal CP. Dengue en Barbosa (Santander, Colombia): conocimientos, actitudes y prácticas en la comunidad. Rev Cuba Med Tropical [Internet]. 2023 [citado 28 Ene 2025]; 75 (1) . Disponible en: <https://revmedtropical.sld.cu/index.php/medtropical/article/view/1026>
13. Sanchez M, Girón K, Navas N, Montaña MA, Gómez KP, Dávila LA, et al. Conocimientos, actitudes y prácticas sobre el dengue, en población escolar de un municipio al norte de Colombia. Rev Cubana Med Trop [Internet]. 2024 [citado el 28

- de enero de 2025];76(0). Disponible en:
<https://revmedtropical.sld.cu/index.php/medtropical/article/view/1203>
14. Jelte E, Masja S, Erley L, Vincenti M, Velasco Z, Arias L, et al. Conocimientos, actitudes y prácticas preventivas frente al dengue en Maracay, Venezuela [Internet]. Nih.gov. 2018 [citado el 28 de enero de 2025]. Disponible en:
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6085811/>
 15. Ministerio de Salud. NORMA TÉCNICA DE SALUD PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE PACIENTES CON DENGUE EN EL PERÚ [Internet]. Gob.pe. 2024 [citado el 28 de enero de 2025]. Disponible en:
<https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/6007546/5323501-r-m-175-2024-minsa-y-nts-211-dgiesp.pdf?v=1709834791>
 16. Moreno E, Gil J. El Modelo de Creencias de Salud: Revisión Teórica, Consideración Crítica y Propuesta Alternativa. Rev Int Psicol Ter Psicol [Internet]. 3(1):91–109. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=56030105>
 17. Health behavior and health education. (s/f). Upenn.edu. Recuperado el 14 de marzo de 2025, de <https://www.med.upenn.edu/hbhe4/part2-ch3-main-constructs.shtml>
 18. Aristizábal G, Blanco D, Sánchez A, Ostiguín R. El modelo de promoción de la salud de Nola Pender: Una reflexión en torno a su comprensión. Enferm Univ [Internet]. 2011 [citado el 28 de enero de 2025];8(4):16–23. Disponible en:
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-70632011000400003&lng=es
 19. Pender NJ, Murdaugh CL, Parsons MA. Health promotion in nursing practice. 7a ed. Upper Saddle River, NJ, Estados Unidos de América: Pearson; 2014.
 20. Documento Técnico: Modelo de Cuidado Integral de Salud por Curso de Vida. [Internet]. Gob.pe [citado el 12 de agosto de 2025] Disponible en:
<https://docs.bvsalud.org/biblioref/2020/12/1050369/mci.pdf>

ANEXOS

Matriz de consistencia del Proyecto

Pregunta de Investigación	Objetivo General	Objetivos Específicos	Hipótesis	Variables	Indicadores
¿Qué relación existe entre el nivel de conocimientos sobre el dengue y las prácticas para su prevención en la población que asiste al Centro de Salud Max Arias Schreiber?	Determinar la relación entre el nivel de conocimientos sobre el dengue y las prácticas para su prevención.	Identificar el nivel de conocimientos sobre el dengue en adultos que asisten en el centro de Salud Max Arias Schreiber del distrito de La Victoria.	<u>Hipótesis nula (H0)</u> : No existe relación significativa entre el nivel de conocimientos sobre el dengue y las prácticas para su prevención.	Nivel de conocimientos sobre el dengue	Conocimiento sobre el vector del dengue. Conocimiento sobre el modo de transmisión. Conocimiento sobre los síntomas y signos iniciales. Conocimientos sobre los signos de alarma. Conocimiento de medidas para eliminar criaderos. Conocimiento sobre protección personal.
		Evaluar prácticas para la prevención del dengue en adultos que asisten al centro de Salud Max Arias Schreiber del distrito de La Victoria.	<u>Hipótesis alterna (H1)</u> : Existe relación significativa entre el nivel de conocimientos sobre el dengue y las prácticas para su prevención.	Prácticas para la prevención del dengue	Mantiene los objetos de almacenamiento de agua tapados y limpios. Elimina los objetos en desuso que puedan acumular agua. Evita tener floreros con agua o los reemplaza con arena. Uso de ropa adecuada. Uso de repelente. Uso de mosquitero.

CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS SOBRE EL DENGUE

El presente cuestionario tiene como objetivo evaluar los conocimientos que posee sobre el dengue, incluyendo aspectos relacionados con su transmisión, síntomas y medidas de prevención. La información obtenida será utilizada únicamente con fines académicos y contribuirá a fortalecer estrategias de prevención en la comunidad.

Por favor, lea atentamente cada pregunta y seleccione la opción que considere correcta.

Datos generales

1. Actualmente reside en el distrito de la Victoria

- a) Sí
- b) No

2. Edad _____

3. Sexo

- a) Masculino
- b) Femenino

4. Mayor grado de instrucción obtenido

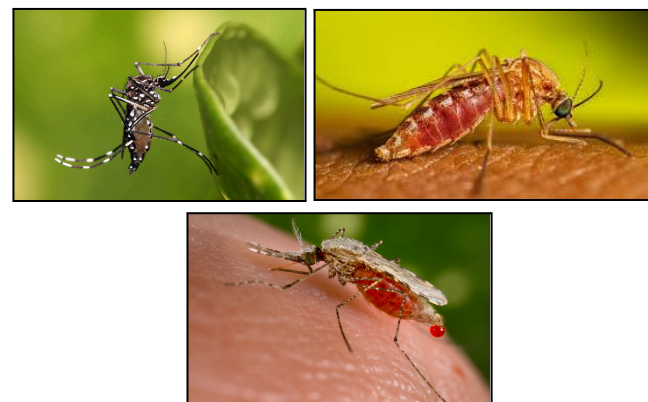
- a) Primaria
- b) Secundaria
- c) Técnica
- d) Universitaria

Datos específicos

1. ¿Cuál es el insecto que transmite el dengue?

- a) Aedes aegypti.
- b) Anopheles.
- c) Culex
- d) No lo sé

2. Marque una equis(x) la imagen correspondiente al zancudo que transmite el dengue.



3. ¿Cómo se transmite el virus del dengue?

- a) Por contacto con una persona enferma.
- b) A través de la picadura de un mosquito infectado.
- c) Por inhalar partículas de aire.
- d) Por consumo de agua contaminada.
- e) No sé

4. ¿En qué momento del día es más probable que el zancudo pique a una persona?
- a) Durante la noche
 - b) En la madrugada
 - c) En las primeras horas de la mañana y el atardecer
 - d) Todas las anteriores
5. ¿Qué síntomas puede presentar una persona con dengue sin signos de alarma?
- a) Fiebre alta, dolor de cabeza, ojos y músculos
 - b) Dolor de cabeza, fiebre alta, tos seca, náuseas
 - c) Náuseas, vómitos, fiebre alta, dolor de cabeza, ojos y músculos
 - d) Dolor de ojos, músculos, cabeza, tos con flema, escurrimiento nasal
6. ¿Qué síntomas puede presentar una persona con dengue con signos de alarma?
- a) Dolor abdominal intenso, vómitos persistentes (3 o más en 6 horas)
 - b) Tos con flema verde, escalofrío
 - c) Somnolencia o irritabilidad, sangrado de mucosas, nariz y encías
 - d) Todas anteriores
 - e) Solo A Y C
7. A que hace referencia el termino " CRIADERO DE ZANCUDOS"
- a) Lugar en donde se encuentran gran cantidad de zancudos en estado larvario
 - b) Objeto o recipiente con agua o sin agua donde el zancudo se reproduce y deja huevos

- c) Cualquier objeto que acumule agua donde el zancudo deja sus huevos
 - d) Todas las anteriores
 - e) No lo sé
8. ¿Qué acciones ayudan a eliminar criaderos del zancudo transmisor del dengue?
- a) Tapar bien los recipientes para almacenar agua.
 - b) Rocíar lejía en lugares donde haya agua empozada
 - c) Eliminar objetos en desuso o basura que puedan acumular agua
 - d) Todas las anteriores
 - e) Solo A Y C
9. ¿Qué acciones ayudan a prevenir la picadura del zancudo?
- a) Usar repelente
 - b) Encender velas aromáticas
 - c) Colocar mosquiteros o mallas en ventanas y puertas
 - d) Usar bloqueador solar
 - e) Todas las anteriores
 - f) Solo A Y C

CUESTIONARIO SOBRE PRÁCTICAS PREVENTIVAS

Este cuestionario tiene como propósito conocer qué medidas de prevención del dengue usted aplica en su vida cotidiana. Sus respuestas nos ayudarán a comprender mejor las prácticas de la comunidad y a reforzar las estrategias de prevención.

Por favor, marque la opción que mejor refleje su comportamiento habitual. No hay respuestas correctas o incorrectas, lo importante es su sinceridad

Preguntas generales

1. ¿Cuentas con servicio de agua potable y alcantarillado?
 - a) Sí
 - b) No
2. ¿Cuáles de los siguientes recipientes usa para almacenar agua cuando hay cortes de agua o no cuenta con el servicio?
 - ☐ Tanque
 - ☐ Cisterna
 - ☐ Tachos
 - ☐ Baldes
 - ☐ Tinas
 - ☐ N.A
3. En los últimos 15 días ¿ha limpiado y tapado los recipientes donde almacena el agua?
 - a) Sí
 - b) No

4. En los últimos 15 días ¿ha eliminado objetos en desuso de su hogar que puedan acumular agua, como llantas, botellas, baldes viejos?
 - a) Sí
 - b) No
 - c) En mi hogar no hay objetos en desuso que puedan acumular agua.
5. Si en su casa tiene flores o plantas en floreros o en recipientes con agua, ¿cada cuanto cambia el agua?
 - A) Cada que recuerdo
 - B) Cada 2 o 3 días
 - C) Cada semana
 - D) No tengo flores o plantas en agua en mi hogar
6. Cuando sabe que va a estar en lugar donde hay gran presencia de zancudos ¿Qué tipo de ropa suele usar?
 - A) Polo manga larga
 - B) Pantalón largo
 - C) Me es indistinto
 - D) A y B
7. ¿Con qué frecuencia usa repelente para protegerse de la picadura de los zancudos?
 - a) Siempre
 - b) A veces
 - c) Nunca
8. ¿Usa mosquitero o mallas en las puertas y ventanas para protegerse de las picaduras de los mosquitos?
 - a) Sí
 - b) No

CÁLCULO DE COEFICIENTE DE VALIDEZ DE CONTENIDO (HERNANDEZ-NIETO)

Cuestionario de conocimientos sobre el dengue

Coeficiente de Validez de Contenido (CVC)									
Item	J1	J2	J3	Sxi	(Mx)	CVCi	Pei	CVC	Interpretación
1	4	4	4	12	4	1	0.037	0.963	Excelente
2	4	3	4	11	3.666666667	0.9166666667	0.037	0.8796666667	Buena
3	4	4	4	12	4	1	0.037	0.963	Excelente
4	4	3	4	11	3.666666667	0.9166666667	0.037	0.8796666667	Buena
5	4	3	4	11	3.666666667	0.9166666667	0.037	0.8796666667	Excelente
6	4	3	4	11	3.666666667	0.9166666667	0.037	0.8796666667	Buena
7	4	3	4	11	3.666666667	0.9166666667	0.037	0.8796666667	Buena
8	4	3	4	11	3.666666667	0.9166666667	0.037	0.8796666667	Buena
							Suma total	7.204	
							CVC total	0.9005	

Cuestionario sobre prácticas para la prevención del dengue

Coeficiente de Validez de Contenido (CVC)									
Item	J1	J2	J3	Sxi	(Mx)	CVCi	Pei	CVC	Interpretación
1	4	4	4	12	4	1	0.037	0.963	Excelente
2	4	4	4	12	4	1	0.037	0.963	Excelente
3	4	3	4	11	3.666666667	0.9166666667	0.037	0.8796666667	Buena
4	4	4	4	11	4	1	0.037	0.963	Excelente
5	4	3	4	11	3.666666667	0.9166666667	0.037	0.8796666667	Buena
6	4	3	4	11	3.666666667	0.9166666667	0.037	0.8796666667	Buena
7	4	3	4	11	3.666666667	0.9166666667	0.037	0.8796666667	Buena
8	4	3	4	11	3.666666667	0.9166666667	0.037	0.8796666667	Buena
9	4	3	4	11	3.666666667	0.9166666667	0.037	0.8796666667	Buena
10	4	3	4	11	3.666666667	0.9166666667	0.037	0.8796666667	Buena
11	4	3	4	11	3.666666667	0.9166666667	0.037	0.8796666667	Buena
12	4	3	4	11	3.666666667	0.9166666667	0.037	0.8796666667	Buena
							Suma total	10.72266667	
							CVC TOTAL	0.8935555556	

JUICIO DE EXPERTOS

Estimado/a Mgtr. Antonia Paulino Chucle se le invita a participar en la validación de contenido del cuestionario que evalúa **conocimientos sobre el dengue**. Por favor calificar cada pregunta según tres criterios:

- **Claridad:** ¿La pregunta es comprensible y no genera ambigüedades?
- **Coherencia:** ¿Está alineada con los objetivos de la investigación?
- **Relevancia:** ¿Evalúa adecuadamente lo que se quiere medir?

Para cada criterio, use la siguiente escala: **Deficiente (1), Regular (2), Bueno (3), Excelente (4).**

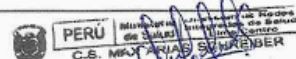
CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS SOBRE EL DENGUE

Item	Calificación				Observación
	1	2	3	4	
1				✓	
2				✓	
3				✓	
4				✓	
5				✓	
6				✓	
7				✓	
8				✓	

Nombre del Juez experto : Mgtr. Antonia Paulino Chucle

Cargo: Enfermera.

Fecha: Lima, 01 de Agosto del 2025



Mg. I. Antonia Paulino Chucle
LIC. ENFERMERA
CEP 65184 RNE 29730

Firma

CEP : 65184

#	Grado	#Registro	Nombre
1	Auditoría	002843	AUDITORÍA EN SALUD
2	Especialidad	029730	ENFERMERIA EN SALUD OCUPACIONAL
3	Maestría	000892	GESTION DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD

JUICIO DE EXPERTOS

Estimado/a Mgtr. Antonia Paulino Chucle se le invita a participar en la validación de contenido del cuestionario que evalúa **prácticas sobre la prevención del dengue**. Por favor calificar cada pregunta según tres criterios:

- **Claridad:** ¿La pregunta es comprensible y no genera ambigüedades?
- **Coherencia:** ¿Está alineada con los objetivos de la investigación?
- **Relevancia:** ¿Evalúa adecuadamente lo que se quiere medir?

Para cada criterio, use la siguiente escala: Deficiente (1), Regular (2), Bueno (3), Excelente (4).

CUESTIONARIO SOBRE PRÁCTICAS PREVENTIVAS

Pregunta	Calificación				Observación
	1	2	3	4	
1				✓	
2				✓	
3				✓	
4				✓	
5				✓	
6				✓	
7				✓	
8				✓	
9				✓	
10				✓	
11				✓	
12				✓	

Nombre del Juez experto: Mgtr. Antonia Paulino Chucle.

Cargo: Enfermera.

Fecha: Lima, 01 de Agosto del 2025


PERU Ministerio de Salud
 Dirección de Redes Integradas de Salud
 Lima Centro
Mgtr. Antonia Paulino Chucle
 LIC. ENFERMERA
 CEP 65184 RNE 29730

Firma

#	Grado	#Registro	Nombre
1	Auditoría	002843	AUDITORÍA EN SALUD
2	Especialidad	029730	ENFERMERIA EN SALUD OCUPACIONAL
3	Maestría	000892	GESTION DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD

JUICIO DE EXPERTOS

Estimado/a Mariluisa Pascal Ampudia, se le invita a participar en la validación de contenido del cuestionario que evalúa **conocimientos sobre el dengue**. Por favor calificar cada pregunta según tres criterios:

- **Claridad:** ¿La pregunta es comprensible y no genera ambigüedades?
- **Coherencia:** ¿Está alineada con los objetivos de la investigación?
- **Relevancia:** ¿Evalúa adecuadamente lo que se quiere medir?

Para cada criterio, use la siguiente escala: **Deficiente (1), Regular (2), Bueno (3), Excelente (4)**.

CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS SOBRE EL DENGUE

Item	Calificación				Observación
	1	2	3	4	
1		✓			Podría agregar o cambiar la interrogante x ¿Sabe Ud. Qué es el dengue? si NO
2			✓		
3			✓		Se podría agregar un inciso e) NO sé
4			✓		
5			✓		
6			✓		
7			✓		
8			✓		Podría agregar a la interrogante que transmite el dengue. / y agregar un inciso d) NO sé

Nombre del Juez experto : Mariluisa Pascal Ampudia

Cargo: Enfermera

Fecha: Lima, 16 de Agosto del 2025



Firma

CEP: 045337

#	Grado	#Registro	Nombre
1	Especialidad	012297	ENFERMERIA EN SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA
2	Maestría	000918	GESTION DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD

JUICIO DE EXPERTOS

Estimado/a Mariluisa Pascal Ampudia, se le invita a participar en la validación de contenido del cuestionario que evalúa **prácticas sobre la prevención del dengue**. Por favor calificar cada pregunta según tres criterios:

- **Claridad:** ¿La pregunta es comprensible y no genera ambigüedades?
- **Coherencia:** ¿Está alineada con los objetivos de la investigación?
- **Relevancia:** ¿Evalúa adecuadamente lo que se quiere medir?

Para cada criterio, use la siguiente escala: **Deficiente (1), Regular (2), Bueno (3), Excelente (4)**.

CUESTIONARIO SOBRE PRÁCTICAS PREVENTIVAS ^{SALUDABLES}

Pregunta	Calificación				Observación
	1	2	3	4	
1				✓	Modificar la palabra objetos por <u>recipientes</u>
2				✓	Modificar la palabra objetos por <u>recipientes</u>
3			✓		
4			✓		Modificar la interrogante ¿Cómo conserva Ud. los floreros en su hogar?
5			✓		
6			✓		También se podría preguntar ¿Con qué frecuencia realiza actividades para prevenir el dengue en su hogar?
7			✓		
8			✓		
9			✓		
10			✓		
11			✓		
12			✓		

Nombre del Juez experto : Mariluisa Pascal Ampudia

Cargo: Enfermera

Fecha: Lima, 16 de Agosto del 2025



Firma

CEP: 045337

#	Grado	#Registro	Nombre
1	Especialidad	012297	ENFERMERIA EN SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA
2	Maestría	000918	GESTION DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD

JUICIO DE EXPERTOS

Estimado/a Lic. M.A. López Moreno se le invita a participar en la validación de contenido del cuestionario que evalúa **conocimientos sobre el dengue**. Por favor calificar cada pregunta según tres criterios:

- **Claridad:** ¿La pregunta es comprensible y no genera ambigüedades?
- **Coherencia:** ¿Está alineada con los objetivos de la investigación?
- **Relevancia:** ¿Evalúa adecuadamente lo que se quiere medir?

Para cada criterio, use la siguiente escala: **Deficiente (1), Regular (2), Bueno (3), Excelente (4).**

CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS SOBRE EL DENGUE

Item	Calificación				Observación
	1	2	3	4	
1				X	
2				X	
3				X	
4				X	
5				X	
6				X	
7				X	
8				X	

Nombre del Juez experto: Lic. Esp. M.A. Isabel López Moreno (Esp. Salud Pública)

Cargo: ENF. RESP. ESP. CIB.

Fecha: Lima, 08 de 09 del 2025

PERU Ministerio de Salud
 Dirección de Vigilancia y Control de Salud
 CENTRO DE SALUD INTEGRADOS DE SALUD C.C.
 MARIA ISABEL LOPEZ MORENO
 RESPONSABLE DE LA ESTRATEGIA TIF

Firma

PERU Ministerio de Salud
 Dirección de Vigilancia y Control de Salud
 CENTRO DE SALUD INTEGRADOS DE SALUD C.C.
 MARIA ISABEL LOPEZ MORENO
 RESPONSABLE DE LA ESTRATEGIA TIF

CEP: 022944

#	Grado	#Registro	Nombre
1	Especialidad	032603	ENFERMERIA EN SALUD PUBLICA

JUICIO DE EXPERTOS

Estimado/a lic. M.A. ISABEL LOPEZ, se le invita a participar en la validación de contenido del cuestionario que evalúa **prácticas sobre la prevención del dengue**. Por favor calificar cada pregunta según tres criterios:

- **Claridad:** ¿La pregunta es comprensible y no genera ambigüedades?
- **Coherencia:** ¿Está alineada con los objetivos de la investigación?
- **Relevancia:** ¿Evalúa adecuadamente lo que se quiere medir?

Para cada criterio, use la siguiente escala: **Deficiente (1), Regular (2), Bueno (3), Excelente (4).**

CUESTIONARIO SOBRE PRÁCTICAS PREVENTIVAS

Pregunta	Calificación				Observación
	1	2	3	4	
1				X	Considerar otros como alternativo
2					
3				X	
4			X		Se puede tener floreros como adorno sin necesidad de contener flores. Sería en caso de tener flores naturales
5			X		Definir clara la pregunta. Presencia de zarzudo en su vivienda? donde?
6				X	
7				X	
8				X	
9				X	
10				X	
11			X		Me parece que no debería de ir en 1era persona la pregunta.
12				X	

Nombre del Juez experto : lic. Maria Isabel Lopez Moreno. (Esp. Salud Publica)

Cargo: ENFERMERA RESP. ES PCTB.

Fecha: Lima, 8 de 09 del 2025

PERU Ministerio de Salud
CENTRO DE SALUD INTEGRADAS DE SALUD L.C.
DIRECCION DE UNIDADES INTEGRADAS DE SALUD L.C.
MARIA ISABEL LOPEZ MORENO
Firma

PERU Ministerio de Salud
CENTRO DE SALUD INTEGRADAS DE SALUD L.C.
DIRECCION DE UNIDADES INTEGRADAS DE SALUD L.C.
MARIA ISABEL LOPEZ MORENO
RESPONSABLE DE LA ESTRATEGIA INC
CEP 22944

CEP: 022944

#	Grado	#Registro	Nombre
1	Especialidad	032603	ENFERMERIA EN SALUD PUBLICA

Kuder-Richardson 20

	Preguntas/Conocimientos									
Individuos	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	
1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	8
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
3	1	1	1	1	0	0	1	0	1	6
4	1	0	1	0	0	0	0	1	1	4
5	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2
6	1	1	1	0	0	1	0	1	0	5
7	1	1	1	1	0	0	1	1	1	7
8	0	1	1	1	0	1	1	1	1	7
9	0	0	0	0	0	1	1	1	1	4
10	1	0	1	0	0	1	0	0	0	3
11	1	1	1	0	1	0	1	0	1	6
12	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3
13	0	0	1	0	0	1	1	1	1	5
14	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3
15	1	0	1	0	0	0	1	1	0	4
16	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2
17	1	1	1	0	0	0	1	1	1	6
18	1	1	1	0	1	1	1	1	1	8
19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
20	1	1	1	1	1	0	1	1	0	7
21	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2
22	1	1	1	1	1	1	1	0	1	8
23	1	1	1	0	1	1	1	0	1	7
24	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3
25	0	0	1	0	1	0	1	0	1	4
26	1	1	1	1	1	0	1	1	1	8
27	1	1	1	0	0	1	0	0	0	4
28	0	1	1	0	0	0	1	1	1	5
29	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
30	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Totales	19	18	24	9	10	15	19	17	21	
p	0.6333333 333	0.6	0.8	0.3	0.3333333 333	0.5	0.6333333 333	0.566666 6667	0.7	
q	0.3666666 667	0.4	0.2	0.7	0.6666666 667	0.5	0.3666666 667	0.433333 3333	0.3	
p*q	0.2322222 222	0.24	0.16	0.21	0.2222222 222	0.25	0.2322222 222	0.245555 5556	0.21	

$\Sigma (p*q)$	2.0022222 22									
varianza	5.5126436 78							KR-20	Interpretación	
k	9							0.9-1	Excelente	
								0.8-0.9	Buena	
k/k-1	1.125							0.7-0.8	Aceptable	
$1 - \Sigma (p*q)/v$	0.636794551							0.6-0.7	Débil	
kr-20	0.7163938699							0.5-0.6	Pobre	
								<0.5	Inaceptable	

	Preguntas/Prácticas						
Individuos	P1	P2	P3	P4	P5	P6	
1	1	1	1	0	0	0	3
2	1	1	1	1	1	1	6
3	0	0	1	0	0	0	1
4	0	0	1	1	0	0	2
5	0	1	1	1	0	0	3
6	0	0	1	1	0	0	2
7	1	1	1	0	0	0	3
8	1	1	1	1	1	1	6
9	0	1	0	1	0	0	2
10	0	1	1	1	0	1	4
11	0	0	0	1	0	0	1
12	0	0	0	0	0	0	0
13	1	0	1	0	0	0	2
14	1	1	1	1	0	1	5
15	0	0	1	1	0	0	2
16	1	1	1	0	0	0	3
17	1	1	1	0	0	0	3
18	1	1	1	1	1	1	6
19	0	1	0	0	0	0	1
20	0	1	1	1	0	0	3
21	1	1	1	1	0	0	4
22	1	1	1	1	0	1	5
23	0	0	1	1	0	0	2
24	1	1	1	0	1	1	5
25	1	0	0	0	0	0	1

26	1	1	1	0	0	0	3
27	0	1	1	1	0	0	3
28	1	1	1	1	0	0	4
29	1	1	1	1	1	1	6
30	0	0	1	0	0	0	1
Totales	16	20	25	18	5	8	
p	0.5333333333	0.6666666667	0.8333333333	0.6	0.1666666667	0.2666666667	
q	0.4666666667	0.3333333333	0.1666666667	0.4	0.8333333333	0.7333333333	
p*q	0.2488888889	0.2222222222	0.1388888889	0.24	0.1388888889	0.1955555556	
$\Sigma (p*q)$	1.184444444						
varianza	2.96091954			KR-20	Interpretación		
k	6			0.9-1	Excelente		
				0.8-0.9	Buena		
k/k-1	1.2			0.7-0.8	Aceptable		
1- $\Sigma (p*q)/v$	0.5999741201			0.6-0.7	Debil		
kr-20	0.7199689441			0.5-0.6	Pobre		
				<0.5	Inaceptable		

TAMAÑO DE MUESTRA

Fórmula para calcular el tamaño de la muestra en poblaciones finitas:

$$n = \frac{Z^2 \cdot p \cdot q \cdot N}{e^2(N-1) + Z^2 \cdot p \cdot q}$$

Donde:

- $Z=1.96$: Nivel de confianza del 95%
- $p=0.5$: Proporción esperada de éxito
- $q=1-p=0.5$: Proporción complementaria
- $e=0.05$: Margen de error

Datos conocidos para el cálculo del tamaño de la muestra:

- $N = 1130$ Tamaño de la población en etapa de vida adulta
- $Z = 1.96$ Nivel de confianza del 95%
- $p = 0.5$ Proporción esperada de éxito
- $q = 1 - p$ Proporción complementaria
- $e = 0.05$ Margen de error

Fórmula para calcular el tamaño de la muestra en poblaciones finitas

$$n = \frac{(1.96)^2 \cdot (0.5) \cdot (0.5) \cdot 1130}{(0.05)^2(1130-1) + (1.96)^2 \cdot (0.5) \cdot (0.5)}$$

Resultado: **288 personas**

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Estimado participante, por medio del presente documento le hago llegar un cordial saludo y a su vez presentar el trabajo de investigación que me encuentro realizando, titulado: **“Nivel de conocimientos sobre el dengue y su relación con las prácticas para su prevención en adultos que asisten a un establecimiento de salud. La Victoria. Lima 2025 ”** El cual tiene por propósito determinar la relación que existe entre el nivel de conocimientos sobre el dengue y las prácticas para su prevención en adultos que asisten al centro de Salud Max Arias Schreiber del distrito de La Victoria.

¿Para qué se firma este documento?

Lo firma para poder constatar y brindar confirmación escrita sobre su voluntad de participar en el estudio.

¿Por qué se está haciendo este estudio de investigación?

Tiene como propósito recopilar información sobre conocimientos y prácticas para la prevención del dengue en adultos que asisten al establecimiento de salud.

¿Qué pasa si digo “sí, quiero participar en el estudio”?

Si dice que sí se le proporcionará una hoja con preguntas relacionadas a los conocimientos que posee sobre el dengue y otra hoja con preguntas relacionadas a las prácticas usted realiza para prevención del dengue. Este estudio no tiene respuestas correctas o incorrectas.

¿Cuánto tiempo tomará el estudio?

El estudio tomará alrededor de 10 minutos de su tiempo.

¿Qué pasa si digo “no quiero participar en el estudio”?

Usted tiene todo el derecho de expresar una negativa frente a su participación y no será tratado de manera diferente. No recibirá penalización de ningún tipo.

¿Qué pasa si digo que sí, pero cambió de opinión más tarde?

Usted puede dejar de participar en el estudio en cualquier momento. No recibirá penalización de ningún tipo.

¿Quién verá mis respuestas?

Las únicas personas autorizadas para ver sus respuestas son las que trabajan en el estudio y las que se aseguran de que éste se realice de manera correcta. Cuando compartamos los resultados del estudio no incluiremos su nombre.

¿Me costará algo participar en el estudio?

No.

¿Qué debo hacer si tengo preguntas?

Si bien no debería haber preguntas durante el estudio, Usted puede realizar su consulta con el encargado encuestador en cualquier momento; o vía telefónico mediante el número 936125880 si surgieran dudas después de finalizar el registro de sus respuestas.

¿Tengo que firmar este documento?

Firme solamente si desea participar en el estudio.

Habiendo sido informado(a) del propósito de esta y teniendo la confianza plena de que por la información que se vierte en el instrumento será única y exclusivamente para fines de la investigación en mención, mi participación es libre y voluntaria, por lo cual firmo este consentimiento informado.

He comprendido la información brindada, quedando satisfecho y brindando consentimiento para mi participación voluntaria en el presente estudio.

Lima,..... de.....del 2025.

Firma

Apellidos y nombres.